

Discours ambulancier inter-hospitalier

Jérôme Jean-Charles, Laurent BEZIA, Benjamin Cornec

Durée : 20 minutes

Bonjour à tous,

Je suis ambulancier inter-hospitalier au CHU de Toulouse, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un métier qu'on connaît peu mais qui est pourtant au cœur de la continuité des soins : le transport sanitaire inter-établissements. Chaque jour, mes collègues et moi assurons la liaison vitale entre Purpan, Rangueil, Larrey et l'Oncopole. Notre mission ? Garantir que chaque patient, quelle que soit sa situation, arrive à destination en sécurité.

Mais cette mission comporte des défis très spécifiques. Je vais vous en présenter deux majeurs : la gestion des patients atteints de maladies infectieuses, et le transport de patients à risque de fugue ou de violence.

1. Les maladies infectieuses : prévenir pour protéger

La première ligne : nos collègues du SAMU

Commençons par saluer nos collègues du SAMU, véritables sentinelles sanitaires. Eux, ils interviennent en première ligne, souvent dans l'urgence, face à des patients dont le statut infectieux est encore inconnu. Une méningite ? Une tuberculose ? Une gale ? Du COVID ? Ils ne le savent pas toujours avant d'arriver.

Certes, la régulation médicale s'est améliorée. Aujourd'hui, on intègre mieux les signes cliniques d'infections contagieuses pour alerter les équipes avant leur départ. Mais sur le terrain, l'incertitude demeure. C'est pourquoi nos collègues appliquent systématiquement les **précautions standards** :

- Lavage des mains ou friction hydroalcoolique avant et après chaque contact,
- Port de gants, masque chirurgical ou FFP2, lunettes ou visière selon les symptômes,
- Adaptation des protections selon les signes cliniques : toux, fièvre, contact possible avec du sang ou des fluides,
- Nettoyage et désinfection rigoureux du matériel et du véhicule après chaque intervention.

Ces gestes, vous les connaissez. Ils sont dans tous les protocoles d'hygiène. Mais face à une suspicion d'infection hautement transmissible, on monte d'un cran :

- Masque FFP2 systématique pour les maladies respiratoires,
- Isolation du patient dans l'ambulance si possible,
- Notification immédiate à l'établissement destinataire pour préparer l'accueil.

Ces bonnes pratiques s'inspirent des recommandations du CDC et des protocoles EMS internationaux. Nos collègues du SAMU font un travail remarquable dans des conditions parfois extrêmes.

Nous, ambulanciers inter-hospitaliers : la deuxième ligne

Nous intervenons dans un **deuxième temps**, après que les analyses aient été réalisées, après que le diagnostic ait été posé ou fortement suspecté. Et c'est là toute la différence.

Quand nous arrivons dans les services de maladies infectieuses, nous avons l'information. Les équipes médicales nous communiquent les recommandations sanitaires précises pour chaque patient : BMR, tuberculose, méningite, isolement contact, isolement gouttelettes, isolement air... Nous pouvons donc **adapter nos gestes en conséquence**.

Mais notre rôle ne s'arrête pas au transport. Nous sommes aussi des **acteurs de prévention**. Pendant nos transferts, nous intervenons dans différents services : post-bloc opératoire, consultations en urgence, soins intensifs... Et là, nous veillons à limiter les risques de maladies nosocomiales et de transmission croisée.

Comment ? En collaborant étroitement avec nos infirmiers et nos référents hygiénistes. Face à un doute, une question sur un protocole, nous ne restons jamais seuls. Nous levons le doute ensemble, nous ajustons les pratiques ensemble.

Et puis il y a ces patients si fragiles : **les immunodéprimés** sortant de greffes lourdes. Pour eux, le danger vient de l'extérieur. Nous devenons leur bouclier. Durant le transport, nous veillons à leur protection maximale : environnement contrôlé, matériel stérile, limitation des contacts. Chaque détail compte.

Pourquoi c'est crucial ?

Parce que l'ambulance est un lieu de soins à part entière. Elle ne doit jamais devenir un vecteur de contamination. Entre deux établissements, nous sommes le maillon qui préserve la chaîne de sécurité sanitaire. C'est une responsabilité que nous prenons très au sérieux.

2. Patients à risque de fugue et de violence : des transports sous haute tension

Passons maintenant au deuxième défi : le transport de patients à risque de fugue ou présentant des comportements violents. C'est un aspect méconnu de notre métier, mais il est quotidien.

Les détenus pénitentiaires

Nous assurons des transports pour les détenus hébergés à l'**UHSI de Ranguel** (Unité Hospitalière Sécurisée Interrégionale) et à l'**UHSA** (Unité Hospitalière Spécialement Aménagée pour les détenus en psychiatrie). Ces patients ont des droits : celui d'accéder aux soins, comme tout citoyen.

Nous les transportons vers des consultations spécialisées, des examens complémentaires, ou le tribunal. Ces transports se font sous escorte : police, gendarmerie, surveillants pénitentiaires. Mais au cœur de ce dispositif sécuritaire, il y a un patient. Et notre mission, c'est d'assurer la **continuité des soins**.

Parfois, nous transportons aussi des patients **fichés S**, escortés par les unités du GIPN comme les IRIS. La tension est palpable, les protocoles sont stricts, mais nous restons des soignants. La sécurité ne doit jamais faire oublier la dignité.

Les patients psychiatriques

Nous intervenons également pour les patients des **unités psychiatriques en secteur fermé**. Accompagnés par des infirmiers du service, nous les conduisons vers des soins somatiques ou au tribunal pour des audiences.

Ces transports demandent une vigilance particulière. Le patient peut être en crise, agité, dans le déni de ses besoins de soins. Nous devons conjuguer fermeté et bienveillance, sécurité et humanité.

Les adolescents et les personnes âgées vulnérables

Nous prenons également en charge les jeunes patients de la **clinique de l'adolescence** présentant de gros troubles du comportement. Ces jeunes sont souvent en grande souffrance. Le transport peut être un moment critique, une occasion de crise ou, au contraire, un moment d'apaisement.

De même, nous transportons des patients des secteurs fermés de gériatrie : unités Alzheimer, troubles cognitifs sévères. Ces patients peuvent être désorientés, anxieux, parfois agressifs par incompréhension. Là encore, notre approche doit être à la fois rassurante et sécurisante.

Les victimes de violences

Enfin, nous assurons le transport de patients admis aux urgences et nécessitant de voir la **médecine médico-légale** : victimes de violences, de viols. Ces patients sont en état de choc, souvent traumatisés. Le transport doit être un cocon, un moment où on leur redonne un peu de contrôle, de dignité. Nous sommes parfois les premiers à poser un regard bienveillant, à offrir une parole rassurante.

Conclusion : un métier complexe, au service de tous

Voilà, en vingt minutes, je vous ai fait entrer dans notre quotidien d'ambulanciers inter-hospitaliers. Un métier où l'on jongle entre hygiène rigoureuse et gestion de crises, entre protocoles sanitaires et humanité.

Nous ne sommes pas que des chauffeurs. Nous sommes des soignants, des acteurs de prévention, des maillons essentiels de la continuité des soins. Nous travaillons avec des patients infectieux, immunodéprimés, détenus, psychiatriques, victimes... Chacun mérite notre professionnalisme, notre respect, notre vigilance.

Et c'est pour cela que la formation continue est vitale. Parce que nos missions évoluent. Parce que les protocoles changent. Parce que chaque patient est unique.

Merci de votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions.

[Applaudissements]